

PHOENIX evaluatiestudie

Fase 1 – onafhankelijke expertgeneratie

Instrument voor Zorgprofessionals

Deelnemerscode: HCP-PRE-05

Toegewezen casussen: **C09** (27-jarige salesvertegenwoordiger) en **C10** (52-jarige operationeel directeur)

Studie	Evaluatie van de klinische kwaliteit van een ontologiegebaseerd multi-agentsysteem voor gepersonaliseerde digitale geestelijke gezondheidszorg (PHOENIX)
Instelling	Universiteit Gent – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Onderzoeker	Stijn Van Severen (masterproefstudent)
Promotoren	Prof. Dr. Geert Crombez; Dr. Annick De Paepe
Contact	stijn.vanseveren@ugent.be
Geschatte duur	Ongeveer 35–45 minuten voor beide casussen samen

Doel van deze bundel

U neemt deel aan een evaluatiestudie waarin zorgprofessionals onafhankelijk dezelfde vijf klinische redeneerstappen uitvoeren als het PHOENIX-systeem. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Voor elk van uw twee casussen vult u dezelfde vijf delen in: (1) operationalisering, (2) initieel observatiemodel, (3) prioritering van behandeldoelen, (4) verfijning van EMA-metingen en (5) een mobiele coachingsboodschap.

We vragen uw eigen klinische oordeelsvorming. Antwoord zoals u dat in een reële professionele context zou doen, maar werk strikt volgens de instructies op de volgende pagina.

Vertrouwelijkheid: uw antwoorden worden voor analyse geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt binnen deze masterproefstudie. Deelname is vrijwillig; u kan zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met de onderzoeker.

Contents

1	Instructiepagina	3
2	Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen	5
3	Deel 2: Initieel observatiemodel	8
4	Deel 3: Prioritering van behandeldoelen	11
5	Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica	14
6	Deel 5: Mobiele coachingsboodschap	17
7	Afronding en terugbezorging	20

1 Instructiepagina

PHOENIX is een multi-agentsysteem dat een vrije klachttekst omzet in een gestructureerde klinische redenering via vijf opeenvolgende stappen. In deze bundel voert u diezelfde vijf stappen onafhankelijk uit voor uw twee toegewezen casussen. Uw antwoorden vormen het menselijke referentiecorpus voor een latere dubbelblinde vergelijking met systeemoutput.

Stap	Klinische taak	Wat u doet	Richttijd
1	Operationalisering	Noteer 2–6 criteriumlabels voor actuele probleemdimensies	≈ 6 min
2	Initieel observatiemodel	Genereer 3–5 biopsychosociale predictor-labels (EMA-geschied)	≈ 6 min
3	Behandeldoelprioritering	Rangschik de 5 standaardpredictoren van hoog naar laag	≈ 7 min
4	Verfijnd observatiemodel	Selecteer exact 5 EMA-items uit de lijst van 20	≈ 8 min
5	Mobiele coaching	Schrijf een korte patientgerichte boodschap voor de app	≈ 8 min
Totaal (2 casussen)			35–45 min

Werkwijze – strikt te volgen

1. **Werk sequentieel: Deel 1 → Deel 5.** Ga pas naar een volgend deel wanneer het huidige deel volledig is afgewerkt voor beide casussen.
2. **Gebruik geen generatieve AI, schrijfhulpmiddelen, richtlijnen of collegaoverleg.** Extern gebruik ondermijnt de methodologische validiteit en de blind scoringswaarde van de studie.
3. **Gebruik in latere delen uitsluitend de meegeleverde gestandaardiseerde context.** Die is bewust vastgezet zodat alle deelnemers op identieke input reageren.
4. **Herwerk eerdere antwoorden niet retroactief** nadat u latere context hebt gezien.
5. **Noteer of typ rechtstreeks in de voorziene antwoordzones.** Onleesbare of ambigu geformuleerde antwoorden bemoeilijken latere blind beoordeling.

EMA-principes (relevant voor Deel 2 en Deel 4)

Ecological Momentary Assessment (EMA) meet dagelijkse schommelingen via een mobiele app. Elke EMA-variabele moet aan vier vereisten voldoen:

- **Dagelijks rapporteerbaar** via een korte vraag op de smartphone.
- **Dynamisch en veranderbaar:** geen vaste diagnose, trait of achtergrondkenmerk.
- **Meetbaar in een eenvoudig format:** ja/nee, aantal, minuten of een 0–10 score.
- **Klinisch relevant voor opvolging:** toont binnen-persoonsvariatie die therapeutisch informatief is.

In **Deel 2** genereert u zelf predictorlabels. In **Deel 4** zijn de 20 kandidaat-items reeds uitgewerkt als dagelijkse EMA-items; u selecteert de meest geschikte 5.

2 Deel 1: Operationalisering van mentale gezondheidsproblemen

Instructies Deel 1

Opdracht: identificeer de belangrijkste actuele probleemdimensies in de klachttekst en noteer voor elke dimensie uitsluitend een **kort criteriumlabel**.

Wat telt als criterium? Een klinisch relevante probleemdimensie die:

- momenteel aanwezig is in de casus,
- inhoudelijk apart te onderscheiden is van andere probleemdimensies,
- in principe herhaald meetbaar zou kunnen zijn.

Antwoordformat: label van 2–5 woorden, zonder beschrijvende zin. Noteer per casus **2–6 criteria**. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger

“Mijn stemming kan op een dag heel snel omslaan en vaak lijkt dat sterker dan wat er feitelijk gebeurt. Ik kan mij in de ochtend nog redelijk voelen en tegen de middag helemaal ontredderd zijn. Wanneer ik mij bekritiseerd of afgewezen voel, zelfs om iets kleins, reageer ik extreem heftig – boos of heel wanhopig. Ik handel ook impulsief, vooral met geld of in relaties, en heb daar achteraf spijt van. Mijn relaties worden vaak snel intens en lopen daarna mis. Ik zie dat dat patroon zich herhaalt, maar ik weet niet hoe ik het moet doorbreken.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterium 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterium 6 Label (2–5 woorden): _____

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur

“De werkstress is het grootste deel van het afgelopen jaar blijven oplopen. Ik heb voortdurend spanning-shoofdpijn en mijn maag is op de meeste dagen ontregeld. 's Nachts lig ik wakker over werkproblemen en beslissingen die nog genomen moeten worden, en als ik eenmaal wakker ben geraakt, val ik vaak niet meer in slaap. Ik drink bijna elke avond twee of drie glazen wijn om tot rust te komen. Ik weet dat dat niet ideaal is, maar het voelt alsof ik anders niet kan afschakelen. Mijn beweging is volledig weggevallen en ik snap thuis sneller dan vroeger.”

Opdracht: noteer **2–6 criteriumlabels** voor deze casus. Gebruik enkel korte labels; voeg geen beschrijving toe.

Criterion 1 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 2 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 3 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 4 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 5 Label (2–5 woorden): _____

Criterion 6 Label (2–5 woorden): _____

3 Deel 2: Initieel observatiemodel

Instructies Deel 2

Opdracht: genereer **3–5 biopsychosociale predictorlabels** die een initieel observatiemodel vormen voor deze casus.

Wat telt als predictor? Een veranderbare factor die:

- klinisch plausibel samenhangt met een of meerdere criteria,
- geschikt is voor **dagelijkse Ecological Momentary Assessment (EMA)**,
- door de persoon zelf eenvoudig via een mobiele app kan worden gerapporteerd.

Antwoordformat: enkel een label van 2–6 woorden, zonder meetdefinitie of toelichting. Laat ongebruikte velden leeg.

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger – Deel 2

27-jarige salesvertegenwoordiger; duur: 3 jaar. Snelle stemmingsschommelingen, uitgesproken afwijzingsreactiviteit, impulsief gedrag en relationele instabiliteit.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Snelle stemmingsschommelingen
- **CR-2** Afwijzingsreactiviteit
- **CR-3** Impulsief gedrag
- **CR-4** Relationele instabiliteit

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur – Deel 2

52-jarige operationeel directeur; duur: ongeveer 9 maanden. Chronische werkstress, doorslaapinsomnie, somatische stressklachten en alcoholgebruik als coping.

Gestandaardiseerde criteria uit stap 1:

- **CR-1** Chronische werkstress
- **CR-2** Doorslaapinsomnie
- **CR-3** Somatische stressklachten
- **CR-4** Alcohol als copingstrategie

Opdracht: noteer **3–5 predictorlabels** voor een initieel observatiemodel. Zorg dat elk label later dagelijks via een mobiele app meetbaar kan worden gemaakt.

Predictor 1 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 2 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 3 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 4 Label (2–6 woorden): _____

Predictor 5 Label (2–6 woorden): _____

4 Deel 3: Prioritering van behandeldoelen

Instructies Deel 3

Opdracht: rangschik de **5 standaardpredictoren** van **hoogste** naar **laagste** klinische prioriteit als behandeldoel.

Gebruik voor uw rangschikking:

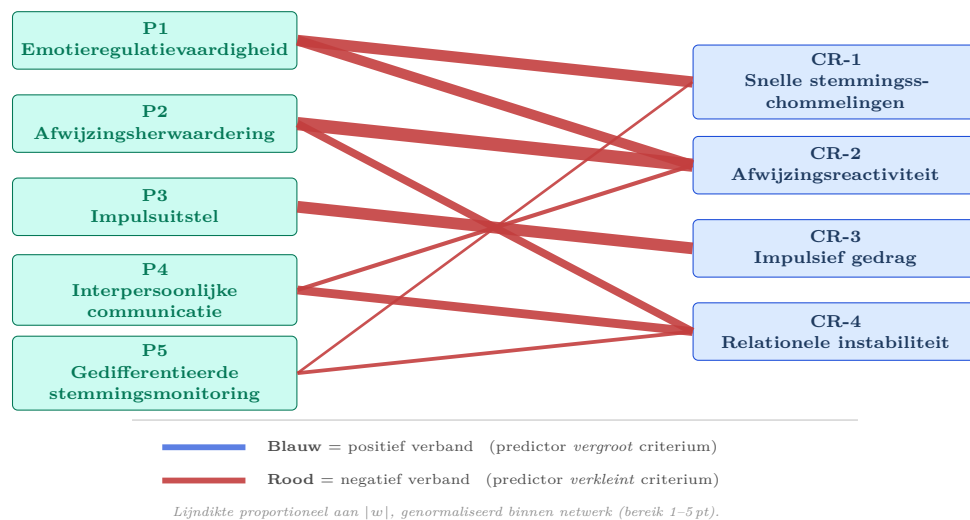
- de 21-daagse monitoring,
- de bipartiete netwerkstructuur,
- de mate waarin een predictor meerdere criteria kan beïnvloeden.

Antwoordformat: vul alle prioriteitslijnen in, van 1 tot en met 5.

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger – Deel 3

Snelle stemmingsschommelingen, uitgesproken afwijzingsreactiviteit, impulsief gedrag en relationele instabiliteit. Duur: 3 jaar.

21-daagse monitoring: Dagelijks stembereik: gem. 5,8 punten. Emotieregulatievaardigheden gebruikt: gem. 1,2/dag. Impulsieve handelingen: gem. 2,1/dag. Interpersoonlijke conflicten: gem. 3,8/week. Ervaren afwijzingssignalen: gem. 2,4/dag. Herwaardering voor reactie: gem. 0,7/dag.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Emotieregulatievaardigheid, P2: Afwijzingsherwaardering, P3: Impulsuutstel, P4: Interpersoonlijke communicatie, P5: Gedifferentieerde stemmingsmonitoring

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

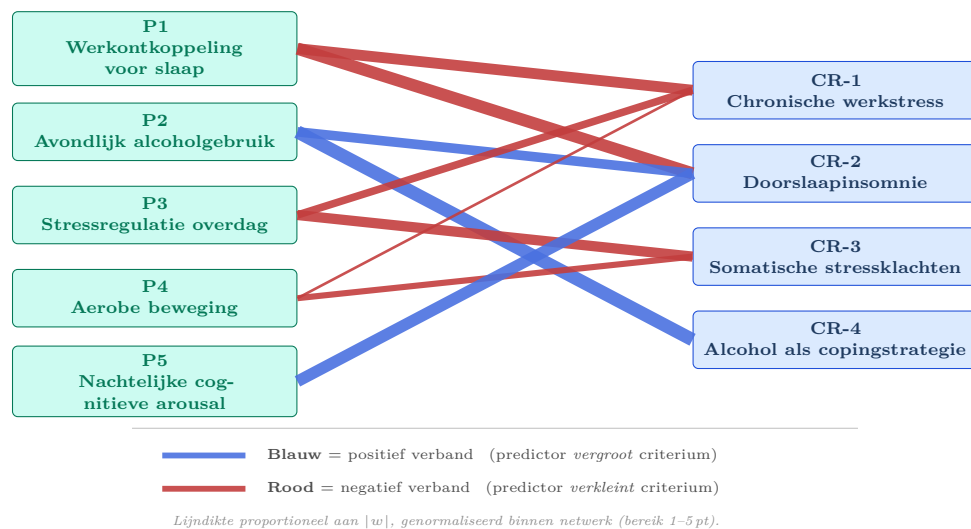
Prioriteit 4

Prioriteit 5

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur – Deel 3

Chronische werkstress, doorslaapinsomnie, somatische stressklachten en alcoholgebruik als coping.
Duur: ongeveer 9 maanden.

21-daagse monitoring: Werkgerelateerde gedachten na 20.00 uur: gem. 3,4 uur. Alcoholeenheden in de avond: gem. 3,1. Hoofdpijndagen: 16/21. Slaapefficiëntie: gem. 62%. Stressregulatie overdag: gem. 0,9/dag. Lichamelijke activiteit: gem. 0,4 sessies/week.



Opdracht: rangschik alle 5 predictors van hoogste naar laagste behandelprioriteit. **Beschikbare predictors:** P1: Werkontkoppeling voor slaap, P2: Avondlijk alcoholgebruik, P3: Stressregulatie overdag, P4: Aerobe beweging, P5: Nachtelijke cognitieve arousal

Prioriteit 1

Prioriteit 2

Prioriteit 3

Prioriteit 4

Prioriteit 5

5 Deel 4: Verfijnd observatiemodel via breadth-first update-logica

Instructies Deel 4

Opdracht: selecteer per casus **exact 5 EMA-items** uit een lijst van 20.

Wat bootst dit deel na? PHOENIX verfijnt het observatiemodel via een **breadth-first update-logica**: vanuit de reeds geprioriteerde behandeldoelen wordt gezocht naar de meest geschikte, direct meetbare subpredictoren voor de volgende EMA-cyclus.

Selectieprincipe:

- start vanuit de standaardbehandeldoelen hieronder,
- kies de 5 dagelijkse EMA-items die daar het best op aansluiten,
- verkies klinisch relevante breedte boven irrelevante of perifere items,
- noteer **geen** toelichting of extra commentaar.

Antwoordformat: vink **exact 5** items aan.

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Emotieregulatievaardigheid** (*laag gebruik ondanks groot stembereik; meest directe hefboom voor stabilisatie*)
2. **Impulsuitstel** (*impulsieve handelingen komen frequent voor en voeden relationele schade*)
3. **Afwijzingsherwaardering** (*grootste kloof tussen ervaren afwijzing en voorafgaande cognitieve bijsturing*)

Opdracht: selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Cafeïne-inname na 14.00 uur (aantal)
2. ☐ Slaapduur afgelopen nacht (uren)
3. ☐ Emotieregulatievaardigheid toegepast (ja/nee)
4. ☐ Aantal conflicten op het werk (aantal)
5. ☐ Tijd op sociale media (min)
6. ☐ Impulshandeling uitgesteld (ja/nee)
7. ☐ Eetlust bij avondmaal (0–10)
8. ☐ Ochtendenergie bij ontwaken (0–10)
9. ☐ Afwijzingsherwaardering geprobeerd (ja/nee)
10. ☐ Alcoholinname vandaag (aantal)
11. ☐ Lichamelijke activiteit vandaag (min)
12. ☐ Stemningsbereik vandaag (0–10)
13. ☐ Aantal onafgewerkte taken (aantal)
14. ☐ Concentratie tijdens administratie (0–10)
15. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
16. ☐ Schermtijd na 22.00 uur (min)
17. ☐ Interpersoonlijk communicatiegesprek geoefend (ja/nee)
18. ☐ Sociale media gebruik na werk (min)
19. ☐ Tijd buitenshuis alleen (min)
20. ☐ Nekspanning in de namiddag (0–10)

Totaal geselecteerd: _____ / 5

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur – Deel 4

Gestandaardiseerde behandeldoelen uit Deel 3:

1. **Werkontkoppeling voor slaap** (*momenteel afwezig en direct relevant voor doorslaapinsomnie*)
2. **Avondlijk alcoholgebruik** (*gemiddeld 3,1 eenheden per avond; onderhoudt slaapfragmentatie*)
3. **Stressregulatie overdag** (*laag maar trainbaar; upstream aangrijpingspunt voor CR-1 en CR-3*)

Opdracht: selecteer **exact 5** EMA-items die het best passen als volgende subpredictoren. *Alle antwoordopties zijn dagelijkse mobiele EMA-items.*

1. ☐ Ochtendlichtblootstelling (min)
2. ☐ Preslaap werkontkoppelingsritueel gevolgd (ja/nee)
3. ☐ Middagdutje genomen (ja/nee)
4. ☐ Aantal sociale afspraken na het werk (aantal)
5. ☐ Alcoholeenheden vanavond (aantal)
6. ☐ Eetlust bij avondmaal (0–10)
7. ☐ Hoofdpijnintensiteit in de namiddag (0–10)
8. ☐ Stressregulatiegedrag overdag toegepast (ja/nee)
9. ☐ Schermtijd voor ontspanning na 21.00 uur (min)
10. ☐ Lichamelijke spierspanning in de ochtend (0–10)
11. ☐ Waterinname vandaag (glazen)
12. ☐ Werkgerelateerde gedachten na 20.00 uur (min)
13. ☐ Aantal vergaderuren vandaag (uren)
14. ☐ Slaapduur afgelopen nacht (uren)
15. ☐ TV-kijktijd in de avond (min)
16. ☐ Ochtendstemming bij ontwaken (0–10)
17. ☐ Aerobe beweging vandaag (min)
18. ☐ Cafeïne-inname na 16.00 uur (aantal)
19. ☐ Contact met gezin vandaag (ja/nee)
20. ☐ Aantal maaltijden overgeslagen (aantal)

Totaal geselecteerd: _____ / 5

6 Deel 5: Mobiele coachingsboodschap

Instructies Deel 5

Opdracht: schrijf een korte, patientgerichte coachingsboodschap die rechtstreeks in de mobiele applicatie kan verschijnen.

Gebruik hiervoor:

- het primaire probleem van de casus,
- het geselecteerde behandeldoel,
- de voornaamste barriere,
- de aangegeven copingstrategie.

De boodschap hoort:

- compact genoeg te zijn voor een mobiel scherm,
- warm en professioneel te klinken,
- een concrete eerstvolgende stap te bevatten,
- rechtstreeks tot de persoon gericht te zijn.

Werkvoorbeeld (niet gerelateerd aan een studiecaser):

Context: verpleegkundige met het doel om opnieuw korte beweegmomenten in te bouwen; barriere = vermoeidheid na de shift; coping = een vaste 10-minutenwandeling koppelen aan het thuiskomen.

Voorbeeldboodschap:

“Na een zware shift voelt rust nemen logisch, maar net dat eerste kleine beweegmoment kan je avond helpen ontladen. Trek vanavond meteen na thuiskomst je schoenen aan en wandel 10 minuten buiten, zonder jezelf meer op te leggen dan dat ene blokje. Zo maak je de stap haalbaar en vergroot je de kans dat je lichaam later echt kan afschakelen.”

Casus 1: 27-jarige salesvertegenwoordiger – Deel 5

Primair probleem

Snelle stemmingswisselingen en hevige reactiviteit leiden tot impulsieve beslissingen en relationele escalatie.

Behandeldoel

Een specifieke emotieregulatievaardigheid inzetten zodra spanning begint op te lopen.

Voornaamste barriere

Lage coping-self-efficacy: in het piekmoment verwacht de persoon dat vaardigheden toch niet zullen werken.

Copingstrategie

Gebruik een vooraf geoefende cue-actie-koppeling: herken een vroege lichamelijke cue en koppel die aan exact een vaardigheid.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

Casus 2: 52-jarige operationeel directeur – Deel 5**Primair probleem**

Aanhoudende werkstress leidt tot gefragmenteerde slaap, lichamelijke spanningsklachten en alcohol als vaste ontladingsstrategie.

Behandeldoel

Een korte werkontkoppelingsroutine installeren en alcohol niet langer als standaard afschakelmechanisme gebruiken.

Voornaamste barriere

Sterke gewoontekracht: alcohol voelt essentieel om de overgang van werk naar slaap te maken.

Copingstrategie

Vervang het bestaande gewoontepatroon door een vast, tijdsgebonden afbouwritueel dat elke avond op hetzelfde moment start.

Opdracht: schrijf hieronder de mobiele coachingsboodschap voor deze casus. *Formuleer alsof de tekst morgen rechtstreeks op de smartphone van de persoon verschijnt.*

7 Afronding en terugbezorging

Dank u voor het invullen van alle vijf delen voor uw twee toegewezen casussen (Casus 1 en Casus 2).

Checklist voor terugbezorging

- ☐ Ik heb in Deel 1 voor beide casussen criteriumlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 2 voor beide casussen predictorlabels ingevuld.
- ☐ Ik heb in Deel 3 voor beide casussen alle 5 predictors gerangschikt.
- ☐ Ik heb in Deel 4 voor beide casussen exact 5 EMA-items geselecteerd.
- ☐ Ik heb in Deel 5 voor beide casussen een mobiele coachingsboodschap geschreven.
- ☐ Mijn antwoorden weerspiegelen mijn eigen klinische oordeel zonder gebruik van generatieve AI of andere externe hulp.
- ☐ Ik begrijp dat mijn antwoorden geanonimiseerd worden voor analyse.

Bezorg het ingevulde document terug via e-mail aan:

`stijn.vanseveren@ugent.be` met onderwerp: PHOENIX-PRE-HCP-PRE-05

Na ontvangst worden uw antwoorden geanonimiseerd en opgenomen in het expertreferentiecorpus voor de latere blind evaluatie van PHOENIX. Hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit onderzoek.